

1A. Hombro: anamnesis dirigida

Preguntar primero por el movimiento doloroso, el comportamiento nocturno, la movilidad y las pistas cervicales o traumáticas.

Pregunta literal	Si responde SÍ → orienta	Si responde NO → aporta	Qué explorar después
¿Le duele al elevar el brazo, sobre todo al llegar a la horizontal o entre 60° y 120°?	Dolor relacionado con manguito/espacio subacromial.	Reduce este patrón, pero no excluye tendinopatía o rotura.	Arco doloroso, Hawkins-Kennedy, Neer, Jobe y ecografía.
¿Le duele por la noche o al acostarse sobre ese hombro?	Manguito, BSASD, capsulitis u OA; dato frecuente y poco específico.	Reduce irritabilidad nocturna, no lesión estructural.	Movilidad activa/pasiva y fuerza del manguito.
¿Puede moverlo usted menos de lo que yo consigo moverlo pasivamente?	Rotura relevante, inhibición por dolor o neuropatía.	Hace menos probable pseudoparálisis por manguito.	Comparar movilidad activa/pasiva, fuerza y drop-arm.
¿También está rígido cuando otra persona le mueve el brazo, especialmente al rotarlo hacia fuera?	Capsulitis adhesiva u OA glenohumeral.	Reduce capsulitis/OA rígida; pensar más en manguito.	Rotación externa pasiva, patrón capsular y RX si procede.
¿El dolor está arriba del hombro y aparece al cruzar el brazo o llevar una bolsa?	Articulación acromioclavicular sintomática.	Reduce AC como generador principal.	Palpación AC y cross-body adduction.
¿Tiene dolor de cuello, hormigueos o cambia el dolor al mover el cuello?	Radiculopatía cervical o dolor referido.	Reduce origen cervical, pero no lo excluye.	Spurling, distracción, ULTT, Bakody y neurología.
¿Empezó tras un traumatismo con debilidad súbita o incapacidad para elevar el brazo?	Rotura aguda de espesor completo, fractura o luxación.	Reduce lesión traumática mayor.	RX/eco-RM y derivación preferente según hallazgos.

SÍNTESIS DE ANAMNESIS

La anamnesis debe separar un patrón subacromial, una articulación rígida, una rotura con debilidad verdadera y un origen cervical. El dolor nocturno aislado no localiza la estructura.

1B. Hombro: exploración esencial guiada

Un test solo se considera positivo si reproduce el dolor o el síntoma habitual en la localización esperada. Comparar lados cuando sea apropiado y no diagnosticar por una maniobra aislada.

Test	Cómo se hace	Positivo → qué implica	Negativo → qué implica
Arco doloroso	Abducción activa lenta de 0° a 180° y descenso.	Dolor habitual aprox. 60°-120°; aumenta sospecha de dolor relacionado con manguito/espacio subacromial.	Reduce esa sospecha, pero no excluye tendinopatía ni rotura.
Hawkins-Kennedy	Flexión 90°, codo 90°; estabilizar escápula y llevar pasivamente a rotación interna.	Dolor anterolateral habitual: apoya dolor subacromial/manguito; no identifica bursa frente a tendón.	Disminuye algo la probabilidad; no descarta lesión del manguito.
Neer	Estabilizar escápula; elevar pasivamente el brazo en flexión con rotación interna.	Dolor anterolateral habitual: apoya síndrome subacromial clínico.	No excluye manguito; interpretar con arco y fuerza.
Jobe / full can	Brazo a 90° en plano escapular; pulgar abajo o arriba; resistir descenso.	Dolor: supraespinoso sintomático. Debilidad verdadera: sospechar rotura o neuropatía.	Fuerza indolora reduce rotura relevante, no elimina tendinopatía pequeña.
ER lag sign	Codo 90°; colocar casi en rotación externa máxima y pedir mantener al soltar.	El brazo cae hacia rotación interna: sugiere rotura relevante de infraespinoso/supraespinoso posterior.	Hace menos probable una rotura posterosuperior grande; no excluye parcial.
Belly-press / lift-off	Presionar abdomen sin llevar codo atrás; o separar dorso de mano de zona lumbar.	Compensación, debilidad o incapacidad: lesión relevante del subescapular.	Reduce rotura grande; sensibilidad limitada para lesiones pequeñas.
Cross-body adduction	Elevar brazo a 90° y aducirlo pasivamente sobre el tórax.	Dolor focal superior sobre AC: apoya articulación acromioclavicular.	Hace menos probable AC sintomática, pero no la excluye.
Drop-arm	Abducir pasivamente a 90° y pedir descenso lento y controlado.	Caída brusca/incapacidad: sospechar rotura grande o inhibición intensa; confirmar con imagen.	No descarta rotura, especialmente parcial o compensada.

SÍNTESIS CLÍNICA

Ninguna maniobra aislada diagnostica bursitis o rotura. Combinar localización del dolor, movilidad activa/pasiva, fuerza y 2-3 pruebas concordantes. Si hay parestesias, dolor cervical o reflejos alterados, aplicar la ficha cervical.

1C. Hombro: ecografía, intervención y plan

La ecografía completa debe explicar la concordancia clínica, no convertir cualquier hallazgo degenerativo en el generador.

Plantilla ecográfica básica normal	Qué documentar
Bíceps largo	Centrado en corredera, patrón fibrilar conservado, sin líquido/hiperemia patológica; valoración dinámica.
Subescapular	Continuidad y fibrilaridad en rotación externa; sin defecto focal ni calcificación relevante.
Supraespinoso	Continuidad hasta huella, grosor/ecogenicidad conservados, sin defecto bursal o articular.
Infraespinoso / redondo menor	Fibrilaridad y huella conservadas; sin atrofia evidente.
BSASD	Sin distensión ni engrosamiento significativo; correlación dinámica, no diagnosticar por una cifra aislada.
AC y receso posterior	Cambios AC, derrame glenohumeral y cortical ósea; describir solo lo visible.

Escenario	Intervención posible	Después
Dolor subacromial que impide dormir/rehabilitar	Una infiltración BSASD ecoguiada puede aportar alivio corto; evitar series automáticas y la inyección intratendinosa.	Iniciar carga progresiva de manguito y estabilizadores escapulares en la ventana analgésica.
Dolor crónico intenso de hombro / capsulitis / OA	Bloqueo supraescapular como coadyuvante seleccionado; infiltración glenohumeral si el generador es articular.	Medir movilidad y función; no añadir bloqueo supraescapular de rutina a toda bursitis.
Tendinopatía calcificante sintomática concordante	Lavado/barbotaje ecoguiado o ESWT según tipo/tamaño/fase, experiencia y preferencias.	Revisión precoz por posible reagudización y rehabilitación progresiva.
Rotura completa, joven/deportista, trauma o debilidad	No vender PRP como reparación. Ecografía/RM y valoración traumatológica; una infiltración bursal puede enmascarar sin resolver.	Decisión compartida sobre reparación vs manejo conservador.

PLAN BASE

Ejercicio activo 6-12 semanas: control de carga, movilidad, fuerza progresiva del manguito, serrato anterior y trapecio; fisioterapia supervisada al inicio si hay miedo, técnica deficiente o gran limitación. ESWT: opción sobre todo en tendinopatía calcificante. EMTT/Magnetolith: coadyuvante de evidencia aún emergente, nunca sustituto del ejercicio.

MENSAJE AL PACIENTE

La infiltración no reconstruye el tendón. Buscamos bajar el dolor el tiempo suficiente para recuperar sueño, movimiento y fuerza; la parte que mantiene la mejoría es la readaptación progresiva.

1D. Hombro: pauta práctica

Dosis orientativas para adulto no frágil. Individualizar por edad, peso, embarazo, alergias, función renal/hepática, riesgo GI/CV, anticoagulación y medicación concomitante.

CÓMO PRESCRIBIR

Elegir una sola estrategia analgésica principal, fijar fecha de fin y revisar una tarea funcional. Paracetamol: máximo conservador 3 g/día. No combinar AINE. En paciente de riesgo GI que precise AINE, valorar omeprazol 20 mg/día durante el curso.

Cuadro	Fármaco • dosis	Duración / revisión
Manguito / bursitis	Diclofenaco gel 11,6 mg/g: 2-4 g, 3-4 veces/día; si precisa vía oral: ibuprofeno 400 mg/8 h O naproxeno 250 mg/12 h.	Gel 7-14 días; AINE oral 5-7 días y revisar.
Rescate	Paracetamol 500-1.000 mg/8 h si precisa (máx. 3 g/día).	3-5 días; no mantener si no aporta función.
Calcificación reactiva	Ibuprofeno 400 mg/8 h O naproxeno 250-500 mg/12 h si es seguro.	5-7 días; reevaluar si dolor intenso persiste.

Bloqueo / técnica	Fármaco propuesto	Volumen y guardarraíl
BSASD	Betametasona depot (Celestone Cronodose) 1 mL; puede asociarse lidocaína 1% según compatibilidad/protocolo.	Total habitual 4-5 mL. Extrabursal/intratendinoso: no.
Glenohumeral	Betametasona depot 1 mL o triamcinolona 20-40 mg + lidocaína 1% o bupivacaína 0,25%.	Total 5-8 mL; aspirar y confirmar diana.
Supraescapular	Ropivacaína 0,2% o bupivacaína 0,25%; sin corticoide de rutina.	5 mL; ajustar si bloqueo distal/proximal y vigilar toxicidad acumulada.
Barbotaje	Lidocaína 1% para piel/bursa + suero salino 0,9% para lavado; corticoide bursal opcional al final.	LA 5-10 mL; lavado 10-30 mL en alícuotas, no como bolo tisular.

REHABILITACIÓN

Programa 6-12 semanas: movilidad, manguito, deltoides, serrato y trapecio; 4-8 sesiones supervisadas si necesita aprendizaje o progresión.

EVITAR

Corticoide intratendinoso, series programadas, PRP como 'reparación' de rotura completa o bloqueo supraescapular automático para toda bursitis.